#한미약품

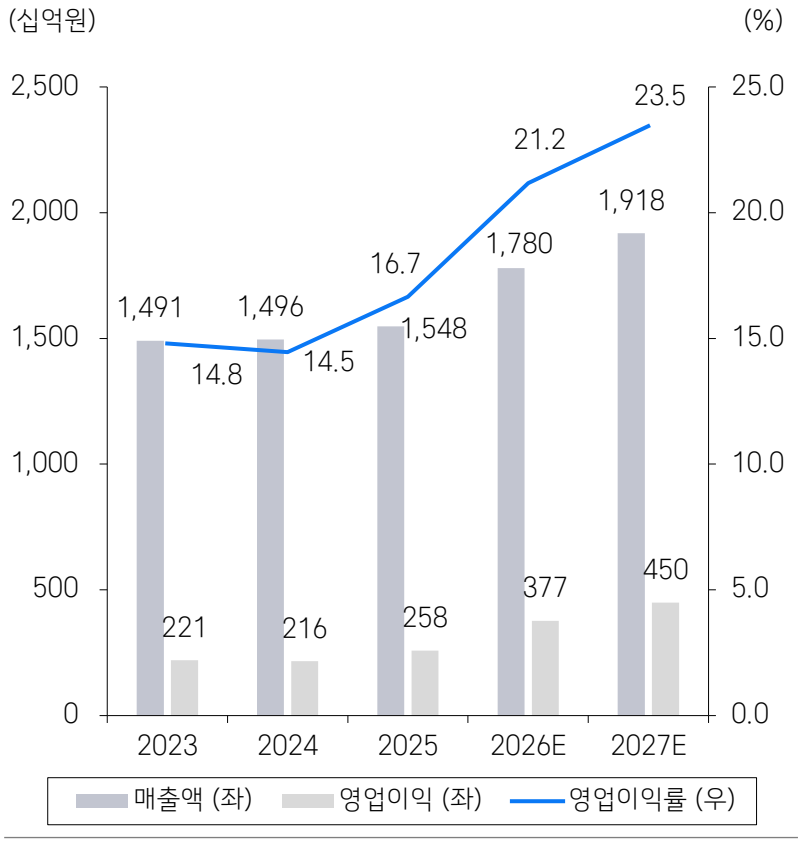
한미약품 (128940)

한미약품 목표 주가 산출

(십억원, 원)	환산 가치	Normalized 12M Fwd EBITDA	EV/EBITDA (배)
영업가치 (A)	3,797	316.4	12.0
신약가치 (B)	3,872	파트너사 / 적응증	임상 단계
소네페글루타이드 (GLP-2)	744	일라이 릴리 / 단장 증후군	P2
에피노페그듀타이드 (GLP/GCG)	518	머크 앤 코 / MASH	P2b
에포시페그트루타이드 (GLP/GCG/GIP)	577	MASH	P2b
HM15275 (LA-GLP/GCG/GIP)	956	비만	P2
HM17321 (LA-UCN2)	1,077	제넨텍 / 비만	P1
순현금 (C)	129		
자본가치 (A+B+C)	7,798		
보통주 수 (D, 천주)	12,811		
적정 주가 (A/D)	608,719		
목표주가 (원)	610,000		

참고: 커버리지 내 대형 제약사 EV/EBITDA 평균 12배
자료: FnGuide, 삼성증권 추정

한미약품 실적 추이 및 전망



자료: 한미약품, 삼성증권 추정

#한미약품

한미약품: 2026년 MASH 파이프라인 성과 기대

한미약품 비만/대사, 희귀질환 파이프라인

파이프라인	기전	적응증	비고
에페글레나타이드	LAPS Exd4 Analog	제2형 당뇨병 비만	임상 3상
에피노페그듀타이드 w/ Merck	LAPS GLP/GCG	MASH	임상 2b상
에포시페그트루타이드	LAPS Triple Agonist	MASH	임상 2상
HM15275	LA-GLP/GIP/GCG	비만	임상 1상 Part b
에페거글루카곤 +에페글레나타이드	LAPS Glucagon Combo	비만/대사성 질환	전임상
HM17321 w/ Genentech	LA-UCN2	비만	임상 1상
에페거글루카곤	LAPS Glucagon Analog	선천성 고인슐린증	임상 2상
소네페글루타이드 w/ Eli Lilly	LAPS GLP-2 Analog	단장 증후군	임상 2상
에페소마트로핀	LAPS hGH	성장호르몬 결핍증	임상 2상
HM15421 w/ GC	LA-GLA	파브리병	임상 1상
에포시페그트루타이드	LAPS Triple Agonist	특발성 폐섬유증	전임상

자료: 한미약품, 삼성증권 정리

주요 모멘텀

HM15275 (LA-GLP/GIP/GCG)	• 비만 P1 Part B 진행; 6월 ADA 학회 발표 • 포스터 발표에서 최고 용량군 4주 투약 후 평균 4% 후반, 최대 10%대의 체중 감량 효과 확인 우수한 내약성에도 주목 • 글로벌 임상 2상 진입, 4월 환자 모집 완료. 2027년 1분기 완료 예정 및 중순 탑라인 결과 발표 목표
에피노페그듀타이드 (GLP/GCG)	• MSD에서 MASH 치료제로 임상 진행 중 • 12월 글로벌 임상 P2b상 종료 및 2H26 탑라인 결과 발표 예상
에포시페그트루타이드 (GLP/GIP/GCG)	• MASH 환자 대상 P2b 진행 중 • 2H26 topline 발표 예상
에페글레나타이드 (GLP)	• 비만/당뇨 P3(국내) 임상 완료 • 4Q26 국내 시판 허가 목표

자료: 한미약품, 삼성증권 정리

#한미약품

Efinopegdutide: MASH 무대에서 승부를 건다

▶Efinopegdutide: 경쟁 지형 속 차별화 전략은 GLP:GCG 2:1 비율이 간에서의 효과와 혈당 안전성 균형에 유리

- 머크의 Efinopegdutide(GLP/GCG) P3 진입을 정당화하려면 MASH 해소 40% 이상, 섬유화 ≥1 stage 개선 30% 이상을 달성해야 하며, 이는 현재 벤치마크인 Survodutide(4.8mg 기준 62%)에 근접하는 수준.
- 다만 수치로 앞설 필요는 없고, GI 부작용(오심 66%, 구토 41%)이 치명적 약점인 Survodutide 대비 "comparable efficacy+better tolerability" 조합이 확인되면 머크의 임상 3상 진입 가능성은 높을 것으로 판단.
- 머크는 F4 환자 대상 MK-6024-017 이미 진행 중이며, 생검 결과가 전 스펙트럼으로의 적응증 확장 가능성을 시사하는지도 중요. (간섬유화 4단계, 간경변 환자)

GLP/GCG MASH 임상 현황

제품명	Survodutide	Pemvidutide	Resmetirom
기업	Boehringer Ingelheim	알티뮨	Madrigal
시가총액	비상장	4.5억 달러	102.7억 달러
개발 단계	임상 3상 진행 중	임상 2b상	허가
타깃	GLP-1/GCG	GLP-1/GCG	THR-베타
투여 주기 및 방법	주 1회(SC)	주 1회(SC)	1일 1회(경구)
임상 기간	48주	24주	52주
환자 수	293명(P2)	212명(P2)	966(P3)
섬유화 악화 없는 MASH 해소 (%)	62%(4.8mg) vs 14% p<0.001	59.1/52.1% vs 19.1% p<0.0001	26-30% vs 9.7% p<0.001
MASH 악화 없는 섬유화 개선 (%)	34-36% (2.4~4.8mg) vs 22% n.s(수치만)*	31.8%/34.5% vs 25.9% p값 미달	24~26% vs 14.2% p<0.001

참조: *, pair-wise 비교는 통계 미달; 시가총액 3월 23일 기준
자료: 각사, 삼성증권

Efinopegdutide P2b 시나리오 가이드

판단	섬유화 악화 없는 MASH 해소	MASH 악화 없는 섬유화 개선	시사점
★서프라이즈	>55%	>40%	P3 전 스펙트럼 확장 (F2—F4)
☑ 합격	40-55%	30-40%	P3 진입, 적응증 좁혀 차별화(cirrhosis or 병용)
△중립	30-40%	20-30%	결정 보류, 서브그룹 분석
✗ 실망	<30%	미달	MASH 포기

자료: 삼성증권

#한미약품

HM17321: UCN2가 쓰는 새로운 처방전, 지방은 빼고 근육은 남긴다

▶HM17321 (LA-UCN2): 동물 모델에서 근손실 없이 지방만 선택적으로 감소 확인. 사람 대상 재현 확인될 시 경쟁력 증가

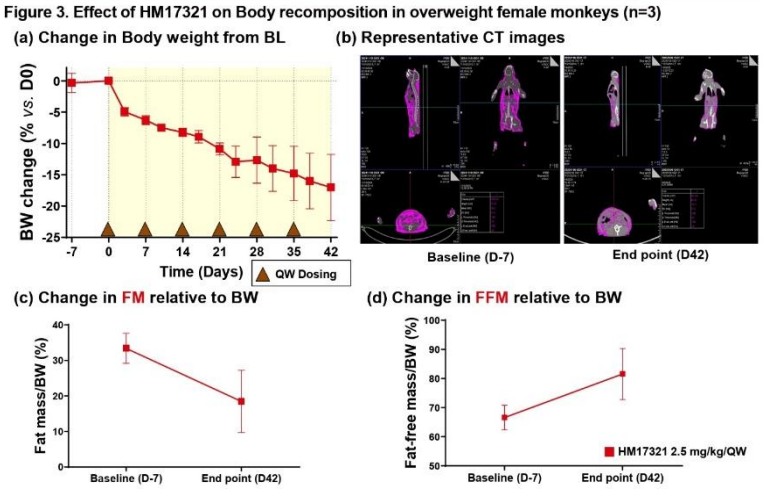
- UCN2는 최근 근감소증 및 근육 질환 치료 분야에서 매우 주목받는 타깃. 특히 근육량 증가와 심혈관 기능 개선 효과.
- UCN2 (Urocortin 2)는 CRHR2에 선택적으로 결합하는 펩타이드 호르몬. 근육 세포에 분포된 CRHR2 수용체가 자극되면 근육 단백질 합성 촉진, 근육 분해 효소 억제, 인슐린 저항성 개선, Myostatin 억제 등의 효과 확인. 현재 약물은 CRHR2에만 99% 이상 선택적 결합으로 설계.
- HM17321: 원숭이 데이터에서 6주 투여 시 17% 체중 감소 확인. Plateau 미도달로 장기 투여 시 추가 감량 가능성 시사. 지방 질량(FM)은 33%에서 19%로 감소한 반면 제지방 질량(FFM)은 67%에서 81%로 증가. 근손실 없이 지방만 선택적으로 감소.

UCN2 기전 파이프라인 개발 현황

구분		비고
RT-100 (P2, 레노바)	유전자 치료제 (AAV8)	UCN2 유전자를 직접 전달하여 장기적 발현 유도 심혈관 개선과 근육 강화를 동시에 노리는 전략 임상 2상 결과: 심박출률(LVEF) 최고 용량 투여 4주 후 5-8.1%p 증가. 심박출압(dP/dt) 좌심실 이완 기능 개선
GUB-UCN2 (P1/2a, Gubra)	펩타이드	쥐 PoC 데이터: Semaglutide 병용 시 근손실 0% 수준으로 방어. 이미 GLP-1 투여로 근육이 빠진 쥐에게 UCN2 추가 투여하자 소실되었던 근육량이 회복됨
HM17321 (P1, 한미약품)	펩타이드	AI(HARP)를 활용해 CRHR2 선택성 극대화, CRHR1 부작용 차단 원숭이 PoC 데이터: 6주 투여 시 대조군 대비 최대 17% 체중 감소에도 근육량 증가 확인(고무적 수준)

자료: 각 사, 삼성증권

HM17321 원숭이 데이터: 지방만 선택적으로 감소 확인



참고: n=3으로 샘플 수가 적기 때문에 통계적 유의성 해석 주의
자료: 한미약품, ADA 2025, 삼성증권

#한미약품

HM15275: GLP-1을 넘어 삼중 작용제로

▶HM15275: GCG 비율 최적화 차별화 및 근손실 최소화 강점. 부작용 프로파일 우위 및 체중 감량 효과 확인 시 Best-in-Class

- HM15275(LA-GLP/GCG/GIP): 삼중 작용제로 현재 임상 2상 중이며, 2027년 상반기 Top line 결과 발표 예상. 1차 완료일은 2027년 1월로 36주 시점의 체중 변화 측정이 완료되는 시점. 2026년 1월 당뇨병 적응증 P2 IND 추가 획득, 상반기 내 개시 예정.
- 릴리의 삼중 작용제와 비교했을 때, HM15275가 게임 체인저가 되기 위한 요건: 1) 체중 감소: 25% 이상의 체중 감소를 보여야 함. Retatrutide가 36주 20-22% 수준 감량 보였음. 2) 체구성의 질: 근육량 보존하면서 지방만 선택적으로 줄이는지 확인. 3) GCG 수용체와 관련된 독성관리: 부작용으로 인한 중단율 10% 이하면 우수한 데이터. 혈당 수치(HbA1c) 안정적 유지 또는 개선도 확인.

일라이 릴리 Retatrutide P3 진행 상황 및 결과

구분	비고
TRIUMPH1-7, Outcomes (비만/OSA/OA)	TRIUMPH-4: 무릎 OA(Osteoarthritis, 골관절염)+비만 환자 대상 12mg, 68주 체중 28.7%↓. WOMAC 통증 75.8%↓, 감각이상 신호 부작용 (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index, 골관절염 평가지수)
	TRIUMPH-1: 비만, OSA(Obstructive sleep apnea, 폐쇄성 수면 무호흡증) 환자 대상 80주 장기 시험으로 +30%↓ 달성 가능 전망. 2026년 결과 발표 예정
	TRIUMPH-2-6: 2026년 결과 발표 예정
TRANSCEND (T2D)	TRANSCEND-T2D-1: T2D+비만 환자 대상 12mg, 40주 HbA1c 최대 2.0%p↓, 체중 16.8%↓, Plateau 미도달 ADA 2026에서 상세 데이터 발표 예정
SYNERGY-Outcomes (MASH)	SYNERGY-Outcomes: MASLD/MASH+간섬유화(F2-F4), 비만 환자 대상 72주 장기 시험으로 2027-2028년 결과 발표

자료: 일라이 릴리, 삼성증권

HM15275 P2 기대 결과

구분		
효능	체중 감소 효능	GLP-1 단일제(15%)나 이중 작용제(20~22%)를 뛰어넘어 25% 이상의 체중 감소 보여야 함
	체구성의 질	단순 체중 감소보다 근육량(Lean Mass)은 보존하면서 지방(Fat Mass)만 선택적으로 줄이는지 중요
안전성	소화기계 부작용	메스꺼움, 구토, 설사 비율이 기존 GLP-1 치료제 대비 낮아야 함. 특히 용량 증량 기간에 발생하는 부작용으로 인한 중단율이 10% 미만이면 매우 우수
	심혈관계 안전성	글루카곤 자극은 심박수를 높일 수 있음. 혈압 강하 및 심혈관 보호 효과 관찰된다면 독성 우려 불식
	대사 독성	글루카곤은 이론적으로 혈당을 올릴 수 있으나, HM15275는 GLP-1/GIP와의 최적 밸런스를 통해 이를 상쇄하도록 설계. 따라서 혈당 수치(HbA1c)의 안정적 유지 또는 개선 확인

자료: 삼성증권